

02 - 01-TD Semiologie Dermatologie - Pr. SAID AMAL

D'accord, on va commencer donc cette séance interactive de sémiologie dermatologique. Ce qui est important dans cette sémiologie dermatologique, c'est d'identifier les lésions élémentaires. Les lésions élémentaires, c'est quelque chose de capital en dermatologie et c'est l'objectif principal de ce cours.

Vous avez fait le cours, donc là, ce sont des séances de révision interactive. Vous posez les questions. On va commencer par, il n'y aura que des images.

Il n'y a pas de texte. Vous avez le texte, vous avez le mécanisme lésionnel. Donc là, c'est quoi la lésion élémentaire ici? Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? C'est une forme de bruit.

Oui, c'est une émacule hérétémateuse, très bien. On voit également que certaines lésions sont surélevées, donc il y a également des papules. Et on va voir l'émacule.

On va voir ici. C'est l'émacule hérétémateuse, donc l'émacule hérétémateuse, c'est une modification de la couleur de la peau. D'accord, quelle est cette couleur ici? Elle est rouge.

C'est pour cela qu'on parle d'émacule hérétémateuse. Donc, lorsqu'on est devant d'émacules de couleur rouge, il y a certains gestes qu'il faut faire. Il faut faire la vitre aux pressions.

C'est quoi la vitre aux pressions? La pression, c'est en fait, on fait une pression sur cette lésion. On voit à travers normalement une vitre aux pressions, c'est à dire à travers un morceau de verre. Vous faites une pression et lorsque vous faites la pression, la lésion, il va disparaître ou persister.

Persister, disparaître. Persister ou disparaître. Persister.

Persister, pourquoi? Parce que ce n'est pas vasculaire. Hein? Ce n'est pas vasculaire. Donc, lorsqu'on fait une pression, la lésion va disparaître.

Il persiste dans quelle pathologie? Dans quel type d'émacule, la lésion persiste? La macule perpérique. Macule perpérique, parce que dans le macule perpérique, vous avez une extravasation du son en dehors des vaisseaux. Ici, dans une macule hérétémateuse, vous avez une vasodilatation.

D'accord? Donc, lorsque vous faites une pression, on parle des vaisseaux au niveau de la peau. Lorsqu'on fait une pression, vous allez faire une vasoconstriction. Donc, vous allez chasser le son qui est dans les vaisseaux et la lésion, il va disparaître.

Vous enlevez la pression et la lésion va reprendre. Donc là, c'est une macule hérétémateuse. Dans ces macules hérétémateuses, ça peut parfois être localisé.

Ça peut parfois être diffuse. En fonction de l'étendue des lésions et de l'aspect, on parle d'un exantème. Lorsqu'on a des lésions diffuses comme ça, on parle d'exantème.

À ce moment-là, on a trois types d'exantème. On a l'exantème morbilliforme. Ou morbilliforme.

Donc, c'est des macules avec des intervalles de peau saine. Pourquoi on a appelé cet exantème comme ça? Parce qu'il y a une pathologie qui s'appelle la rubéole. Et on a ce type d'exantème.

C'est pour cela qu'on parle d'exantème morbilliforme. Il y a l'exantème scarlatiniforme. Et dans l'exantème scarlatiniforme, vous avez des érythèmes diffus sans intervalles de peau saine.

Et vous avez un exantème rosielliforme. Lorsqu'on est devant des macules qui sont un petit peu roses. En général, roses, donc des petites lésions roses au niveau du tronc.

Parce qu'il y a une pathologie également qui s'appelle la roséole infantile. Et on a ce type d'exantème. La scarlatine, c'est la même chose.

Il y a une pathologie de la scarlatine où on a ce type d'érythème. Donc, pour récapituler, les macules érythémateuses, ce sont des macules dus à une hyperémie sanguine à cause d'une vasodilatation au niveau de la circulation cutanée superficielle au niveau de la peau. Ça peut être localisé.

Ça peut être généralisé. Lorsqu'il est généralisé, ça peut être morbilliforme, scarlatiniforme, aurogélifera. Vous avez des questions sur les macules érythémateuses? C'est clair.

Avant d'avancer, c'est bon? Pas de questions? Je ne vois pas les commentaires parce que je ne peux pas, en même temps, voir les commentaires et faire la présentation. S'il y a des questions, prière d'activer vos micros et poser vos questions. Oui, c'est trois types d'érythèmes, ils sont diffus, ils ne sont pas localisés.

Oui, lorsqu'on parle d'exanthème morbilliforme, scarlatiniforme, aurogéliforme, c'est lorsqu'on est devant des macules diffus. Parce que vous avez une seule macule, c'est une macule érythémateuse. Vous avez une petite macule, le malade peut présenter une petite macule.

À ce moment là, on parle de macule érythémateuse, on ne parle ni de scarlatiniforme, ni de ribioliforme, ni de rosieriforme. C'est bon? Oui, monsieur. Merci.

On avance. Donc là. Quelle est la lésion élémentaire? Si vous voyez ces lésions là, cette lésion.

Oui, allez-y, allez-y. Allez-y rapidement pour gagner du temps. C'est quoi comme lésion élémentaire? Est-ce que c'est une macule? Est-ce que c'est une papule? C'est une visécule? C'est une macule.

Très bien. C'est une macule, donc macule. Toujours rappelez-vous, macule, il n'y a pas de relief.

La définition de macule, c'est simple, modification de la couleur de la peau. Donc, il n'y a pas de relief, c'est à dire qu'il n'y a pas une surélévation. On ne parle rien.

Il n'y a pas une infiltration, c'est à dire que la lésion, il n'infiltré pas la peau en profondeur. Donc, si vous fermez vos yeux et vous palpez, est-ce que vous allez sentir quelque chose? Non, parce qu'il n'y a pas de relief, il n'y a pas d'infiltration en profondeur. C'est une simple modification de la couleur de la peau.

Maintenant, dans les macules, on a vu une macule érythémateuse. Donc, macule érythémateuse, ici, la couleur est rouge. Mais est-ce que c'est une macule érythémateuse? C'est une macule? C'est un érythème scarlatiniforme? Non, ce n'est pas un érythème scarlatiniforme.

C'est une macule perpérique? Non. Comment on va faire la différence entre macule érythémateuse et macule perpérique? La vitre pression. Dans les macules perpériques, la vitre pression, les lésions persistent.

Ici, si on fait la vitre pression, la lésion va persister. Donc, comment on va faire la différence entre les macules érythémateuses qu'on vient de voir tout à l'heure et cette lésion? Donc là, ce sont des macules vasculaires. Macule vasculaire.

C'est quoi la différence entre une macule vasculaire et une macule érythémateuse? Rappelez-vous le mécanisme lésionnel. Une macule érythémateuse, elle est due à quoi? Dans les pathologiques, dans les lésions qu'on vient de voir tout à l'heure. On a dit que la scarlatine, la rosaïole, l'exanthème, vous avez des macules érythémateuses.

Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une vasodilatation. Il y a une vasodilatation et il y a une hyperémie. Il y a une inflammation.

Parce que ce sont des infections. Il y a de la température. Il y a une vasodilatation.

Il y a un afflux du sang important. Ici, vous avez un problème au niveau du vaisseau. Ce sont des malformations vasculaires.

Ce sont des vaisseaux. Il y a une anomalie de la paroi. Dans les macules érythémateuses, vous avez des anomalies dans le contenu.

Vous avez un afflux du sang qui est important. Là, vous avez des parois vasculaires qui sont altérées et vous avez bien sûr du sang. C'est pour cela que vous avez cette macule.

Donc, ça ressemble aux macules érythémateuses, mais ce sont des macules vasculaires parce que ce sont des anomalies vasculaires. Et là, pour les lésions qu'on vient de voir tout à l'heure, est ce que c'est des lésions qui vont persister? Des lésions qui vont régresser. On va traiter l'infection et il n'y aura plus de macules érythémateuses.

Dans la scarlatine, on va donner les antibiotiques et la lésion va régresser. Ici, est ce que si on donne un traitement, les lésions vont régresser? Non, parce qu'ici, il faut traiter les vaisseaux. On peut, par exemple, à ce moment là, on peut traiter par les lasers ou etc.

Mais c'est un problème vasculaire. Est ce que vous arrivez à faire cette distinction entre macules érythémateuses et macules vasculaires? Vous avez compris cette différence cliniquement? Il se ressemble. Oui, est ce que les macules vasculaires ne s'effacent pas à la vitre aux pressions? Ils s'effacent à la vitre aux pressions.

C'est comme les macules érythémateuses. Parce que lorsque vous faites une vasoconstriction, vous chassez le son, donc la lésion régresse. Vous enlevez la pression, il revient.

C'est comme les macules érythémateuses. De l'hémacule purpurique, les purpurins, vous voyez qu'ils ne s'effacent pas à la vitre aux pressions. Un neige, parce que dans les purpurins, vous avez le son en dehors des vaisseaux.

Vous avez l'altération de la paroi vasculaire et vous avez le son en dehors des vaisseaux. Donc, lorsque vous faites une vasoconstriction, la lésion persiste. D'accord, d'accord.

Même chose. Donc, macules érythémateuses, vous avez une anomalie du contenu. Vous avez une hypérémie sanguine.

Macules vasculaires, vous avez un problème de la paroi vasculaire. C'est des lésions qui persistent parce que c'est une malformation vasculaire et dans les macules purpuriques. Donc là, qu'est ce que vous voyez ici? Qu'est ce que vous voyez? Quoi? Les lésions élémentaires? Ce sont des vaisseaux dilatés et la macule vasculaire.

Donc c'est des vaisseaux dilatés. Donc ici, c'est une ce sont des macules vasculaires. Donc, les macules vasculaires, on peut les voir dès la naissance dans les malformations vasculaires, mais on peut les voir également.

On parle de telangiectasis. Donc, ce sont des telangiectasis et des macules vasculaires. Et lorsqu'ils prennent cette élongiectasie, lorsqu'ils prennent forme d'étoile, comment on les appelle? Angiome Angiome S De forme d'étoile Angiome plan Angiome stellaire Angiome stellaire, l'angiome plan c'est ça, ce que vous avez vu ça Hadawa l'angiome plan, c'est ça Il ne faut pas connaître les noms des pathologies hein On ne va pas vous poser des questions sur l'angiome plan, sur n'importe quelle pathologie On vous pose des questions sur les lésions élémentaires On cite les pathologies juste comme des exemples D'accord? Donc ce n'est pas l'appel d'apprendre l'angiome plan Donc c'est ça l'angiome plan Une malformation vasculaire depuis la naissance Donc là ce sont des élongiectasies Et lorsque cette élongiectasie prend l'aspect d'étoile, on parle d'angiome stellaire Très bien Dans quelle pathologie on voit les angiomes stellaires? Dans l'insuffisance hépatocellulaire souvent Très bien, dans l'insuffisance hépatocellulaire, c'est parmi les manifestations cutanées de l'insuffisance hépatocellulaire Donc on avance Donc là, la lésion

élémentaire Donc toujours il n'y a pas de relief Il n'y a pas d'infiltration Donc c'est une macule Parce qu'il n'y a pas de relief ni d'infiltration, pas de macule Maintenant vous faites la vitre aux pressions, la lésion persiste Donc c'est une? Macule purpurique Macule purpurique, très bien Là, est-ce qu'il y a un relief? Il n'y a pas de relief, il n'y a pas d'infiltration Donc on est dans l'hémacule Quand il n'y a pas de relief ni d'infiltration, vous êtes dans l'hémacule Est-ce que c'est une macule hérétemateuse? Est-ce qu'elle est de couleur rouge? Quelle est la couleur? Non, donc ce n'est pas une couleur rouge Donc quelle est la couleur ici? Brun Donc c'est une macule brunâtre Et ici? C'est une macule noirâtre Donc c'est quel type de macule ici? Pigmenté Donc l'hémacule pigmenté, très bien L'hémacule pigmenté Donc en général, dans l'hémacule pigmenté, c'est l'excès de la mélanine L'excès de la mélanine Donc pourquoi dans cette lésion, dans les deux lésions, on a un excès de mélanine? D'accord? Est-ce qu'il peut y avoir des macules d'autres étiolos? Est-ce qu'il peut y avoir des macules verdâtres? Par exemple Oui? Oui, vous répondez Des macules verdâtres, est-ce que ça peut exister? En dermatologie Oui? Lors de la disparition des équimoses, elle va se transformer en verdâtre Oui Ou bien, tout simplement, tatouage Tatouage C'est ce qui se dit aussi sur les macules Mais il n'y a pas un pigment mélanique, ça peut être un pigment mélanique ou un pigment exogène Donc lorsque vous avez un tatouage, ce sont des macules D'accord? Donc macule pigmenté Ou bien, il peut y avoir le pigment, c'est la mélanine, ou bien d'autres pigments exogènes Et dans les équimoses, c'est quoi le pigment? Est-ce que c'est de la mélanine? C'est du sang C'est du sang Donc c'est l'hémosidérine D'accord? Donc c'est des macules, très bien D'accord, donc chaque fois que vous avez une modification de la couleur de la peau, c'est une macule Donc ici, macule pigmenté Donc dans ces deux exemples, vous avez C'est l'excès de la mélanine Mais pourquoi dans cette lésion, vous avez une lésion qui est brunâtre Et ici, une lésion qui est un petit peu, on va dire, noire-bloître? Les deux ont le même mécanisme Il y a un excès de la mélanine Et pourquoi la couleur est différente? Ici, c'est dans le site d'accumulation Hein? Le site d'accumulation Donc c'est la profondeur Ici, vous avez le pigment, il est profond au niveau du derme Et donc la couleur au niveau de la surface vous donne cet aspect Ça, c'est la loi de la spectrophotométrie Chaque fois que le pigment a une, lorsqu'il est en profondeur, la couleur de la surface varie Donc là, vous avez le pigment, il est épidermique On a cette couleur brunâtre Et là, c'est profond Oui? Quelle est la lésion élémentaire? Les macules achromiques Les macules achromiques, très bien Lorsqu'on parle de macules achromiques, c'est-à-dire, ce sont des macules Vous avez la couleur de l'eau? Claire Claire, eau C'est quoi cette couleur que vous voyez? Blanche Blanchâtre D'accord Donc vous êtes devant une macule Lorsqu'on parle de macule achromique ou de macule claire ou de macule blanchâtre Un jour, on a posé une question à l'examen La macule achromique est une macule blanchâtre Les étudiants n'ont pas entouré ça Pourquoi quelqu'un ne m'inquiète pas dans le cours? Je ne m'inquiète pas dans le cours, mais qu'est-ce que c'est une macule blanchâtre? Ça c'est une macule blanchâtre Donc une macule achromique, une macule claire, une macule blanchâtre, c'est la même chose D'accord? Donc ici, il y a un mécanisme, c'est qu'il n'y a pas de mélanine Ou les mélanocytes ne fonctionnent pas Donc on a terminé avec les macules hérétemateuses, macules vasculaires Donc macule purpurique, macule pigmenté,

macule achromique Est-ce qu'on est dans les macules ici? Est-ce qu'il y a un relief? Oui, il y a un relief Chaque fois qu'il y a un relief, il faut voir le contenu Est-ce que le contenu est solide ou est-ce que le contenu est liquide? Cliniquement, parfois c'est évident, parfois c'est difficile Donc lorsque vous avez un doute entre le contenu liquidien ou solide d'une papule, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend un vaccin hostile, une petite aiguille et on perce Il y a du liquide qui sort, donc vous avez un contenu liquidien, sinon c'est le contenu solide Donc ici ce sont des lésions relief avec contenu solide Donc on est dans quelles lésions élémentaires? Les papules Les papules, très bien Donc ce sont des papules Donc les papules, il peut y avoir des papules épidermiques C'est-à-dire que le mécanisme de formation de cette papule concerne l'épiderme Ou bien des papules dermiques On va voir quelques exemples, par exemple ici Donc ici la couleur de la lésion, comment elle est? Là, vous prenez cette lésion La couleur, comment elle est? La couleur Quelle est la couleur? Hein? Rouge D'accord, couleur rouge Ici il y a un relief Donc on n'est pas dans les macules érythémateuses Parce que vous avez un relief, lorsque vous fermez les yeux, vous palpez, vous trouvez que les lésions sont surélevées D'accord, donc on est dans des papules, ce sont des papules érythémateuses Et là, dans cette papule érythémateuse, on voit que le mécanisme ici, pourquoi il y a cette... Parce qu'il y a une inflammation au niveau du derme, il y a une vasodilatation, c'est pour cela que vous avez la couleur rouge Donc là vous avez, c'est des lésions au niveau du derme, parce que les vaisseaux n'existent que au niveau du derme Il n'y a pas de vaisseau au niveau de l'épiderme Donc il y a une vasodilatation avec une réaction inflammatoire Donc on devine ici que c'est une papule ondémateuse C'est une papule dermique ondémateuse Donc là vous voyez, est-ce que vous voyez ces lésions là? Donc il y a des surélevations Donc on est dans les papules Mais ce n'est pas érythémateuse, ce n'est pas ondémateuse Donc là, on fait une biopsie, vous voyez les points de suture, c'est la biopsie cutanée Donc là on fait une biopsie cutanée pour voir quel type de papules Épidermique, dermique et quel type de papules dermiques Dans les papules dermiques, par exemple, si vous prenez ces lésions là, quelle est la couleur de cette lésion? Bleu Hein? Un aspect jaunâtre Ce sont les cellules qui sont jaunes Donc vous voyez, c'est des papules, papules jaunâtres Ce sont les cellules qui existent au niveau de l'organisme qui ont un aspect un petit peu jaunâtre Ornées Les cellules Adipeuses Les cellules adipeuses, très bien Donc les cellules adipeuses, les cellules adipeuses sont jaunâtres Et là, c'est une papule Les cellules adipeuses, elles existent où? Est-ce qu'elles existent au niveau de l'épiderme, au niveau du derme ou au niveau du lipoderme? Lipoderme Au niveau du lipoderme Mais ici, vous avez des cellules graisseuses au niveau du derme Donc lorsqu'on fait une biopsie ici, on va trouver qu'il y a des cellules graisseuses au niveau du derme Est-ce que les cellules graisseuses existent au niveau du derme? Non Donc ici, on parle de papules par dépôt de substances anormales Donc il y a des maladies, des maladies, ils disent l'épidémie que vous allez voir par la suite On a une surcharge au niveau de la graisse et ça donne ces lésions On appelle ces lésions, on les appelle les xanthomes Mais ce qui est important pour vous, c'est de savoir que ce sont des papules par dépôt de substances anormales Ça veut dire que ce sont des substances qui normalement n'existent pas au niveau du derme Donc il y a la mylose, la mycelose, beaucoup de maladies qu'on appelle les maladies de

surcharge C'est bon? C'est bon pour les papules? Donc vous avez les papules épidermiques, dermiques, dermoépidermiques Et dans les papules dermiques, vous avez les papules dermiques odémateuses Les papules dermiques par dépôt de substances anormales Ou les papules dermiques par un infiltrat cellulaire inflammatoire C'est-à-dire que dans les papules inflammatoires, vous avez des pathologies On peut avoir des papules par, par exemple, un infiltrat de type granulomoteux Par la sarcoïdose, la subarquidose, etc.

Donc est-ce que ce sont des lésions qui ont un relief? Vous avez un relief? Oui. Donc là, relief, le contenu, comment il est? Donc si on prend un vaccin hostile, on perd cette lésion, il y a du liquide qui sort Donc on est dans les lésions à contenu liquidien Donc ici, c'est quoi comme lésion élémentaire? Les vésicules. Les vésicules, très bien.

Les vésicules, c'est des lésions de contenu liquidien, de petite taille, quelques millimètres de diamètre Et le contenu, il est clair Si le contenu est périllant, on parle de quoi? Si la même lésion mais le contenu est périllant? Pustules. Pustules, très bien. Et si la lésion est supérieure à 0,5 cm? Ce sont des bulles.

Ce sont des bulles, très bien. Donc là, ce sont des vésicules Et là, là, est-ce que ce sont des vésicules? Ce sont des bulles. Ce sont des bulles, très bien.

Ce sont des bulles. Et comment ces bulles sont? Donc c'est des bulles qui sont tendues. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Là, c'est une bulle.

Vous voyez, ça, c'est une bulle. C'est quoi la différence entre cette bulle et cette bulle? Cette bulle, comment elle est? Elle est sèche. Ah, elle fait allure liquide.

Cette bulle, elle est tendue. Vous voyez, elle est tendue. Cette bulle, on dit qu'elle a un aspect laiterie.

Elle est flasque. Pourquoi cette bulle, elle est flasque? Et pourquoi cette bulle, elle est tendue? C'est à cause du siège de la bulle. Donc la bulle, elle peut être de siège intra-épidermique.

Elle peut être de siège thermique. Donc lorsqu'il est... Il faut se rappeler qu'au niveau de la peau, la peau est comme un mur. C'est comme un mur.

Pour construire un mur, qu'est-ce qu'on utilise? Pour construire un mur, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les briques. Et pour faire solidariser les briques entre eux, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le ciment. Donc si maintenant vous voulez construire un mur, vous déposez les briques et il n'y a pas de ciment entre les briques.

Qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? Dissociation. Il y aura dissociation. Il y aura un vide.

Ce vide, c'est la bulle. La même chose au niveau de la peau, vous avez... Quelles sont les cellules qui constituent l'épiderme? Comment on appelle les cellules qui constituent l'épiderme?

Les kératinocytes. Les kératinocytes.

Il y a une jonction qui s'appelle la jonction interkératinocytaire. C'est comme le ciment. Dans certaines pathologies, comme ici par exemple, dans cette pathologie, vous avez une destruction.

C'est une maladie auto-immune, le pemphigus. Destruction de la jonction interkératinocytaire. Et vous aurez un vide.

Vous aurez des bulles parce que les kératinocytes sont séparés. Là, vous avez entre l'épiderme et le derme la même chose. Il y a une jonction dermoépidermique.

Lorsqu'il y a une altération de cette jonction, vous aurez des bulles. Ici, c'est des bulles intraépidermiques. Ici, c'est des bulles sous-épidermiques.

Lorsque vous avez une bulle intraépidermique, chaque bulle est plongée dans le toit. Lorsque vous avez une bulle intraépidermique, le toit de la bulle, comment il est? Puisque la bulle est à l'intérieur de l'épiderme. Le toit de la bulle, comment il est? Est-ce qu'elle est épaisse ou est-ce qu'elle est mince? Mince.

Elle est mince. Très bien. Si le toit de la bulle est mince, quel est le risque pour cette bulle? La perte de la substance.

Elle va se remplir facilement. Lorsqu'elle se remplit facilement, elle va laisser place à une... Comment on appelle ça? Est-ce que c'est une bulle? C'était une bulle. Elle était comme ça, mais elle s'est remplie.

Elle laisse place à une érosion. C'est une perte de substance superficielle. Une érosion.

Une érosion post-bulleuse. Donc vous avez une bulle intraépidermique. La bulle est flasque.

Le toit de la bulle est mince. Elle se remplit facilement. Elle laisse place à une érosion.

Ici, vous avez une bulle sous-épidermique. Le toit de la bulle est tendu. Elle peut se remplir également, mais en général, elle est tendue.

Dans le pemphigus, il y a un signe qu'il faut chercher. C'est quoi ce signe? Le signe de Nikolsky. Le signe de Nikolsky.

Est-ce que vous avez vu le film du signe de Nikolsky? On va le montrer, le flicage de la faculté. On vous le passe maintenant? Non. Je ne sais pas ce que vous dites.

Est-ce que vous pouvez dire autre chose? Non, monsieur. Vous ne pouvez pas? D'accord. On va le... Je vais le faire une autre fois.

C'est bon? C'est clair? Donc là, c'est quoi la lésion alimentaire? Des pustules. C'est des pustules.

Très bien.

C'est des pustules, des lésions de petite taille continue périllant. Donc lorsqu'on est devant des lésions, des pustules, Il faut voir si c'est des pustules qui sont folliculaires ou non. Donc là, est-ce que c'est des pustules folliculaires ? Donc les pustules folliculaires sont des pustules qui sont centrées par un poral.

Donc ici ce sont des pustules folliculaires. Donc là, cette jeune fille présente plusieurs lésions. Donc nous, on est concerné par là, mais là, c'est quelle lésion ici ? Quelle est cette lésion ? C'est quoi ? C'est périllant.

C'est des pustules, très bien. C'est des pustules que vous voyez ici. Donc c'est quelle pathologie ? C'est des pustules là, au niveau du visage, chez une jeune fille.

C'est l'acné, très bien. Donc on ne parle pas de ça, on parle de cette lésion. D'accord ? Cette lésion, est-ce que c'est une macule pigmentée ? Elle est noire.

C'est une lésion noire. Est-ce que c'est une macule pigmentée ? Non, parce qu'elle est surélevée. Elle est surélevée, très bien.

Donc elle est surélevée. Donc lorsqu'on a des lésions surélevées, on a dit qu'il faut voir si elle est contenue liquide ou solide. Donc ici, elle est contenue solide.

Mais elle est supérieure à 1 cm. Donc c'est une lésion arrondie, supérieure à 1 cm. On parle d'une nodule.

C'est une lésion nodulaire. Donc ici, si vous prenez cet exemple là. Cette lésion là, c'est quoi comme lésion ? C'est une lésion avec un relief, contenue solide.

C'est quoi comme lésion alimentaire ? Allez-y, on vient de voir. Papule, très bien. Et là, la taille est différente.

C'est la même pathologie, mais la taille de la lésion est différente. Donc ici, c'est une papule et ici, c'est une lésion nodulaire. C'est un nodule.

Donc vous voyez, la différence nodule et papule. Donc chez ce malade, on va dire qu'il présente des lésions papulonodulaires. Donc, lorsque vous décrivez les lésions, lorsqu'on fait un examen d'hermatologie, il faut décrire la lésion.

Avec un groupe d'hermacules ou de papules, la taille, la couleur, le regroupement, la topographie. Donc chez ce malade, on va dire qu'il présente des lésions papulonodulaires. Donc, pourquoi ? C'est la même pathologie.

Pourquoi ce malade présente des papules et pourquoi il présente des nodules ? Ça traduit quoi ? Prenons cet exemple, c'est plus facile. Lésion nodulaire ici, elle est due à quoi cette lésion ?

Prolifération cellulaire. Prolifération cellulaire, quel type de cellules il y a ? Les mélanocytes.

Les mélanocytes, c'est pour cela que vous pouvez les reconnaître en classe peignoirade. Donc cette prolifération cellulaire, elle peut être bénigne ou maligne. Donc ici, c'est bénigne ici.

Donc c'est un névus là, c'est un névus. Si c'est une prolifération maligne, comment on va appeler ça ? Avec les mélanocytes. Prolifération maligne, prolifération bénigne des mélanocytes, c'est un névus.

Prolifération maligne des mélanocytes. Mélanome. Mélanome, très bien.

Donc ici, c'est la même chose. Vous avez des proliférations cellulaires. Mais pourquoi ici vous avez des papules et ici vous avez des nodules ? Rappelez-vous les papules.

Ils peuvent être dûs à des papules épidermiques, dermiques ou dermo-épidermiques. Donc ici, il y a une prolifération cellulaire, mais la différence entre papules et nodules, ici c'est une prolifération feyna. C'est une prolifération où ? Au niveau de l'épiderme, là, au niveau du derme, là, au niveau de l'hippoderme.

C'est une prolifération ici au niveau du derme. Et lorsque c'est une prolifération, ici c'est des fibroblastes. Lorsque vous avez une prolifération, donc c'est une papule, par un infiltré cellulaire au niveau du derme.

Ici, vous avez la prolifération, elle est profonde, au niveau de l'hippoderme. C'est pour cela que vous avez des lésions nodulaires. Est-ce que c'est clair, les nodules ? Monsieur, s'il vous plaît ? Oui ? Comment différencier entre des papules épidermiques et dermiques ? Papules, c'est dermique.

Il n'y a pas de papules épidermiques. Non, c'est différent. C'est la taille.

C'est dermique. Parfois, c'est difficile, c'est la biopsie. Ici, vous avez la même pathologie.

Donc, la même pathologie, vous avez une prolifération cellulaire. Ici, c'est profond, c'est l'hippoderme. Ici, c'est le derme.

Mais lorsque vous avez une papule isolée, parfois, c'est difficile de faire la part entre papules épidermiques et dermiques. C'est la biopsie cutanée, à ce moment-là. C'est le cas de la maladie au risque de la biopsie cutanée.

D'accord ? Mais ici, vous avez les deux lésions. Donc, ça veut dire que vous avez un infiltrat inflammatoire, dermique et épidermique. Lorsque ça arrive au niveau de l'hippoderme, ça donne des nodules.

Et ici, ça donne des papules. C'est bon ? Oui, c'est bien compris. Maintenant, vous avez cette

lésion-là.

Donc, c'est quoi le diagnostic ? La couleur, comment est la couleur ? Prenez cet exemple, cette lésion, par exemple. La couleur de cette lésion, c'est quoi ? Rouge. Hein ? Rouge.

D'accord. Il n'y a pas de relief. Donc, il n'y a pas de surélévation.

Donc, macule. Ce n'est pas une macule. Érythème ? Non, ce n'est pas une macule.

L'érythème, c'est une macule. Macule érythémateuse. Ce n'est pas une macule.

Il n'y a pas de relief. Il n'y a pas d'infiltration ? Sans relief, ni infiltration. Lorsqu'on ferme les yeux et on palpe, on ne sent rien.

Ici, il y a une infiltration. L'infiltration, c'est-à-dire, si vous palpez, vous allez trouver qu'il y a une infiltration en profondeur. Que c'est une lésion qui se prolonge en profondeur.

D'accord ? Ce n'est pas une simple modification de la couleur de la peau. Donc ici, c'est la palpation qui va vous aider dans le diagnostic. Donc ici, vous avez des lésions qui vont infiltrer le derme profond et l'hippoderme.

Donc ici, on est dans les nourrices. Donc, il faut faire attention. Les nourrices, parfois, il peut y avoir une surélévation.

Comme ici. Mais parfois, il n'y a pas de surélévation, mais il y a l'infiltration. Donc, rappelez-vous, macule, c'est sans relief ni infiltration.

Donc ici, ce sont des nourrices. Donc ici, c'est une lésion nodulaire qui s'est ramollie puis s'est fistulisée. Comment on appelle ça ? Au départ, c'est une lésion nodulaire.

Comme on vient de voir tout à l'heure. C'était comme ça, une lésion nodulaire. Mais elle devient fluctuante et puis elle se fistulise.

Elle se fistulise, ça veut dire qu'il y a un orifice de communication entre la lésion et la peau. Comment on appelle une lésion nodulaire qui se ramollie puis se fistulise ? C'est une gomme. Donc ça, c'est une gomme.

Donc là, toujours, il faut voir s'il y a une continuité de l'épiderme. Est-ce qu'il y a une continuité de l'épiderme ? Non, parce que l'épiderme est continue, comme ça. Donc, lorsqu'il n'y a pas de continuité de l'épiderme, vous avez une perte de substance.

Mais ici, vous avez ces lésions. Est-ce que ce sont des lésions ? Elles sont au-dessus de la surface de la peau. Elles ont un aspect comme ça, en souffleur.

Comment on appelle ça ? C'est de la végétation. C'est de la végétation, très bien. En fait, ici,

vous avez une perte de substance, donc vous avez une ulcération et vous avez des végétations, donc c'est une lésion ulcéro végétante.

Ici, prenez cette lésion-là. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est un aspect de peau sèche, dure, épaisse. On appelle ça une kératose.

Et là, qu'est-ce que vous voyez ici ? Cette lésion-là. Est-ce qu'il y a une continuité de l'épiderme ? Ce que vous voyez ici. Non, donc c'est une perte de substance.

Cette perte de substance, comment elle est ? Les linières et les superficielles, on parle de fissures. Donc ici vous avez une kératose et cette kératose touche la plante du pied, les deux pieds. Donc on parle de kératodermie plantaire.

C'est une kératodermie plantaire. Vous avez une hyperkératose au niveau de la plante du pied, ça peut être palmaire, plantaire, ça peut être les deux. On parle de kératodermie palmo-plantaire, on parle de kératodermie plantaire en fonction de la localisation.

On peut dire que c'est une kératodermie plantaire fissuraire parce qu'il y a des fissures. Donc il peut y avoir l'intrication des lésions élémentaires. Donc ça c'est très important pour décrire la lésion élémentaire.

En dermatologie, les boutons, on décrit, on donne le nom. Donc c'est un alphabet qu'il faut apprendre. Donc ici, la même chose, vous avez un épaissement de la peau, d'accord ? Donc une hyperkératose.

Ici vous avez des lésions avec un aspect en chouffleur. Donc c'est quoi l'aspect en chouffleur ? Comment on appelle l'aspect en chouffleur sur élévation comme ça ? Végétation. Végétation.

Mais est-ce qu'il ressemble aux végétations qu'on vient de voir ? Quelle est la différence ? Non. Donc ici vous avez des végétations, mais la surface est kératosique. D'accord ? La surface est kératosique.

Vous avez les végétations, mais qui sont kératosiques, qui sont épaisses. Donc on parle ici de véricosité. Donc véricosité, elle associe les végétations avec la kératose.

C'est bien. Ça c'est très important. Parce que c'est à partir de ces lésions qu'on peut évoquer les diagnostics.

Mais nous, en tant que dermatophores, les lésions végétantes, par exemple chez ce malade, on a des lésions végétantes. On va penser à un spinocellulaire ou à un cancer, un A. Lorsqu'on a des végétations véricosité, on pense à une tuberculose cutanée, on pense à des mycoses profondes, parce que les pathologies se caractérisent par la nature des lésions élémentaires. C'est pour cela que c'est très important de connaître les lésions élémentaires.

Donc ce ne sont pas les mêmes diagnostics qu'on va évoquer. C'est pour cela que la description est importante. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez ? C'est quoi ça ? Des squam.

Des squam, très bien. Des morceaux de peau qui se décollent de la peau. Donc on parle de squam.

Dans les squam, il y a quatre types de squam. Ce que vous voyez ici, c'est les quatre types de squam. Donc ici, c'est une des squamations qu'on appelle une des squamation scarlatiniforme.

Vous avez la peau qui se décolle, soit sous forme de gant, qui prend l'aspect de la main, soit parfois sous forme du doigt. Donc ce sont des morceaux de peau qui se décollent en lombo. Lombo, c'est-à-dire que ce sont des morceaux de peau.

Lombo, c'est ce qu'on utilise en chirurgie plastique. Lorsqu'on veut couvrir, par exemple, une paire de substances, on prend un lombo d'un autre côté pour donc réparer la paire de substances. Donc ça, on parle de lombo.

Ce sont des morceaux de peau qui se décollent. Pourquoi on appelle ça des squamations scarlatiniformes ? Parce que dans la scarlatine, à la fin de la scarlatine, vous avez cette des squamation. Qu'est-ce que c'est que la scarlatine ? Qu'est-ce que c'est que la scarlatine scarlatiniforme ? Le début.

L'érythème. L'érythème. Donc dans la scarlatine, qu'est-ce qu'on appelle un érythème scarlatiniforme ? Donc on a un érythème sans intervalle de peau de sein.

Et puis, à la fin de la scarlatine, qu'est-ce qu'on appelle un décollement cutané ? Des squamations sous forme de lombo. D'accord. Et si vous avez... C'est quoi l'hésion élémentaire ici ? Qu'est-ce que vous voyez ici ? C'est facile, allez-y.

Une peau blanchâtre. Comment on appelle une peau blanchâtre ? Parce que c'est mieux. La lésion élémentaire.

Lorsque vous avez une lésion blanchâtre, son relief... Macule acromique. C'est une macule... Macule acromique. C'est une macule acromique.

Donc cette macule acromique... Acromique. Macule acromique. Très bien.

Macule blanchâtre, macule acromique. Mais avec cette macule acromique, si vous avez des squames, si vous grattez, vous prenez une curette, ou la base longue, et vous grattez, vous allez obtenir des squames fines, blanchâtres, comme la farine. Et on parle à ce moment-là de des squamations pityriaziformes.

Parce que dans cette pathologie, le pityriasis versicolor, vous avez ces macules acromiques avec les squames. Donnez-moi un exemple de pathologie avec des macules acromiques.

Vitiligo.

Vitiligo. Très bien. La différence par exemple entre vitiligo et pityriasis versicolor, pityriasis versicolor, si vous avez des squames, l'existence de ces squames blanchâtres fines permet de faire la différence entre les deux pathologies.

Ici, c'est une mycose. Champignon. D'accord ? Donc ici, qu'est-ce que vous voyez ? Prenez cet exemple-là.

Donc vous avez des lésions. Ici, c'est des plaques. C'est des plaques érythémateuses.

Voyez l'érythème ici ? Recouverte de ces squames. Ces squames, ils sont blanchâtres, ils sont épais. Voyez la différence ? Donc là, on parle de squames pityriaziformes.

Par exemple, cette maladie s'appelle le pityriasis. Et dans le pityriasis, vous avez ce type de squames. Ici, qu'est-ce que vous voyez ? Une desquamation à petits morceaux.

Ici, c'est des squamations qui ressemblent à quoi ? Aux écailles de poissons. Elles ressemblent aux écailles de poissons. Donc ici, on parle de dermatoses éctiosiformes.

Donc vous avez des squamations scarlatiniformes, pityriaziformes, éctiosiformes, pityriaziformes. Donc ici, il y a plusieurs pathologies qui peuvent donner ça. Là, il y a des éctioses héréditaires, par exemple.

Donc qu'est-ce que vous voyez ici ? Une peau desséchée. Hein ? Qu'est-ce que vous voyez ici ? Des croûtes. Donc ici, ce sont des croûtes.

Pourquoi ces croûtes, elles sont jaunâtres ? Donc les croûtes, c'est l'assèchement du contenu d'une lésion à contenu liquidien. Donc ici, il y avait des pustules. Les pustules se remplissent, et l'assèchement des puits forme des croûtes jaunâtres.

Ou là, des bulles à contenu périllant. D'accord ? Parce que le contenu était périllant. Donc vous avez ici des croûtes périllantes.

Ça peut être des croûtes rouges. Ce sont des croûtes rouges. C'est du sang coagulé.

Ici, c'est du puits qui est asséché. C'est bon pour les croûtes ? Donc là, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a une continuité de l'épiderme ? Non, donc on est dans les pertes de substance. Dans les pertes de substance, vous avez les fissures qu'on vient de voir tout à l'heure.

Une perte de substance linéaire. Vous avez les érosions lorsqu'il y a une perte de substance superficielle. Et vous avez les ulcérations.

Est-ce que c'est une érosion ou une ulcération ? Ici, c'est une ulcération, parce que c'est une perte de substance profonde. L'érosion respecte la membrane basale. Donc c'est superficiel.

C'est comme ce qu'on vient de voir lorsque une bulle se remplit. On a dit que lorsqu'une bulle se remplit, elle laisse place à une érosion. Donc ici, est-ce qu'il y a une continuité de l'épiderme ? Oui.

Oui, donc il n'y a pas de perte de substance. Mais la peau ici, comment elle est ? On voit les vaisseaux. La peau est mince.

La peau est mince. Donc on est dans les atrophies. L'atrophie cutanée.

La peau est mince. On voit les vaisseaux. Et c'est l'atrophie cutanée.

Donc qu'est-ce que vous voyez chez cette jeune fille ici ? Qu'est-ce qu'elle a ? Est-ce qu'il y a une perte de la continuité ? Non. Non, donc on n'est pas dans les pertes de substance. Mais qu'est-ce que vous voyez ici ? Il y a une fente.

Pourquoi il y a cette fente ? Il y a une fente avec conservation de l'épiderme. Donc il y a une atrophie. Normalement, ici, qu'est-ce qu'il y a ? L'atrophie de quelle partie du corps ? De la peau.

Normalement, ici, vous avez les cellules graisseuses. Donc c'est une atrophie d'ILH. De quelle partie ? L'épiderme, l'éderme ou le lipoderme ? Lipoderme.

Lipoderme. Donc il y a une atrophie de lipoderme. Donc il peut y avoir l'atrophie de l'épiderme, l'atrophie de l'éderme, l'atrophie de lipoderme.

Par exemple. D'accord ? Donc c'est une atrophie de lipoderme. On appelle ça l'hypoatrophie.

Ici, normalement, vous avez des plis. Et on arrive à plisser la peau. Ici, c'est difficile de plisser la peau.

Donc on est dans quelle lésion élémentaire ? La sclérose. Hein ? La sclérose, très bien. Donc la sclérose peut toucher juste les doigts.

On parle d'acroscclérose. Il peut toucher les mains. Il peut y avoir une sclérose généralisée.

On parle de sclérodermie généralisée. Et là, c'est l'épicissement au niveau des fibres élastiques et donc au niveau du derme. Ça donne une peau comme ça, donc scléreuse.

Donc on a vu les différentes lésions élémentaires. D'accord ? Donc en dermatologie, il y a deux méthodes pour poser le diagnostic. Il y a ce qu'on vient de voir depuis le début de la séance, ce qu'on appelle l'approche analytique.

On analyse la lésion élémentaire. Et la deuxième étape, après l'analyse de la lésion élémentaire, c'est le regroupement des lésions et la topographie. Ces trois éléments permettent de poser le diagnostic.

Donc même si on ne connaît pas une pathologie, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu cette pathologie, on évoque le diagnostic en faisant cette approche analytique. Identifier la lésion élémentaire, les caractéristiques de la lésion élémentaire, le regroupement et la topographie. Il y a une deuxième méthode pour poser le diagnostic.

Comment on appelle ça ? Par exemple, vous allez assister à la consultation. Il y a cette dame qui vient, par exemple. Je vous donne le diagnostic.

On a vu cette patiente. Je vous donne le diagnostic. Après, vous allez voir une patiente qui a la même lésion.

Et vous allez poser le diagnostic. Sans faire cette approche analytique. Comment vous avez posé le diagnostic ? Vous avez posé le diagnostic par analogie à une image que vous avez déjà vue.

Et là, on parle de l'approche par analogie. Par projection ? Oui. C'est une image que vous avez gardée.

Vous avez vu ce malade. Vous ne savez pas la lésion élémentaire. Vous avez vu des lésions.

Vous avez cette pathologie. Vous avez évoqué le diagnostic. Mais par analogie à une image que vous avez dans votre mémoire.

On appelle ça l'image par analogie. Et ça, c'est en général fait pour les médecins, les résidents en cours de spécialisation pour associer les deux, l'approche analytique et l'approche par analogie. Parce que l'approche par analogie, il faut voir beaucoup d'images, beaucoup d'atlas de dermatologie, beaucoup de malades.

D'accord ? Donc là, on va rester dans l'approche analytique. Donc l'approche analytique, c'est la première chose que nous allons dire. On identifie la lésion élémentaire.

Ce malade, qu'est-ce qu'il a comme lésion élémentaire ? Regardez la lésion qu'il a au niveau du cheveu. C'est quoi comme lésion élémentaire ? Oh mon Dieu, tu m'as fait comme un nain. Ce sont des macules.

Nains ? Macules ? Quel type de macules ? Macules. Erythémateuses. Erythémateuses.

Normalement, on doit faire la vitre pression, ce sont des lésions qui disparaissent, donc on est dans les macules érythémateuses. Ce sont des macules érythémateuses avec ? Vous voyez ici, des squames. D'accord ? Donc ça, c'est la première étape.

La deuxième étape, c'est le groupe nom. Le regroupement, il faut dessiner. Si vous prenez un crayon comme celui-ci, vous dessinez ces limites-là.

Dessinez la limite de la lésion. Comme ça. C'est quel aspect, ça ? Triangulaire.

Les deux. Le regroupement, je mets les lésions. En aile du papillon.

En aile du papillon. Donc Erythème, en aile du papillon, au niveau du visage, chez une jeune fille, le diagnostic, c'est le lupus, qui est une maladie système. Donc comment on a posé le diagnostic ? C'est la lésion élémentaire, le regroupement en aile du papillon et la topographie.

Donc ça, c'est le lupus. D'accord ? Donc si vous voyez une maladie qui a ça, évoquez le diagnostic de lupus. Donc prenons cet exemple-là.

Donc la lésion élémentaire. Vous voyez ça, les lésions élémentaires. C'est des petites lésions.

Vous les voyez ? Des petites lésions qui sont confluentes parfois. Donc c'est des lésions, c'est des pustules et des vésicules et des petites érosions sur une peau qui est érythémateuse. Et la topographie, comment est la topographie ? Le regroupement de cette lésion.

C'est une lésion qui est regroupée sous forme de bande. Et c'est unilatéral. C'est unilatéral, c'est un seul côté.

Donc lorsque vous avez des lésions vésiculeuses, comme ça, ou la pustuleuse sur une peau érythémateuse, unilatérales, ils suivent le trajet normalement d'un nerf. Ici vous avez, rappelez-vous de l'anatomie, vous avez les nerfs intercostaux. Donc ici c'est un zona.

Donc lorsqu'ils suivent le trajet d'un nerf, on parle de zona. Ici vous avez des lésions. C'est quoi les lésions alimentaires ici ? Ce sont des pustules.

Pustules avec des croûtes. Cette localisation, ce regroupement, on va dire qu'on appelle ça un regroupement sous forme de bouquets. Pustules regroupées sous forme de bouquets et sièges au niveau de la lèvre.

Quel est le diagnostic ? Comment on appelle ça ? Herpès. Herpès, très bien. Donc ici vous voyez ces lésions-là ? Cette lésion-là, vous la voyez ? C'est quoi comme lésion alimentaire ? Erosion.

Non, ce sont des pustules. Ah, il y a le contenu blanchâtre. Avec une lésion érythémateuse et squam.

Et cette topographie, comment vous voyez cette topographie-là ? C'est une lésion, le regroupement. Ce regroupement, je me décède. Sous forme d'anneau annulaire ou circulaire avec une tendance à guérison centrale.

La peau centrale est normale. Donc ce regroupement, comme ça, oriente vers les mycoses. Vous voyez que ça c'est important, la lésion alimentaire, le regroupement et la topographie.

Donc la topographie, voici par exemple la topographie. Donc là, c'est quoi la lésion alimentaire ?

Érythème, squam. Mais vous avez ici l'âge.

Tout à l'heure, c'est une femme jeune. On évoque l'hupus. Ici, c'est un nourrisson.

On évoque la dermatite atopique. Vous avez à peu près un placard élémentaire au niveau de la jambe. Là, c'est l'élysipèle.

L'un des couilles de cheveux lus, c'est une mycose. L'un des genoux, c'est le psoriasis. Parfois, vous avez les lésions érythémato-squameuses, mais la topographie et l'âge permettent également d'évoquer le diagnostic.

Et là, ça viendra par la suite. Donc rappelez-vous, la flacémiologie, on ne vous pose pas de questions sur les pathologies. D'accord ? Les lésions alimentaires.

Ce qui est important, c'est les lésions alimentaires. Donc rapidement, on va voir quelques images. Donc là, c'est quoi les lésions alimentaires ? Allez-y, rapidement, pour gagner du temps.

Il ne reste pas beaucoup de temps. C'est des croutes. C'est des croutes.

Très bien. C'est des croutes. Comment elles sont ? Croutes, comment c'est la couleur ? Jeunâtre.

Jeunâtre. Donc ça témoigne qu'il y avait des lésions pustuleuses qui se sont rompues, et il y a l'assèchement. Et vous voyez ces lésions ? C'est quoi cette lésion-là ? Donc il y a des lésions alimentaires.

Ça, les croutes, ce sont des lésions secondaires. C'est l'assèchement. Pustules.

C'est des pustules. Vous avez des pustules et des vésicules sur une peau érythémateuse. Regardez ce placard érythémateur.

Il siège où ? Il y a la première étape, c'est la lésion alimentaire. Deuxième étape, le regroupement et la topographie. Donc cette topographie, est-ce que ça vous oriente vers quelque chose ? Est-ce qu'il y a une atteinte de l'autre côté ? Non.

Donc c'est une atteinte unilatérale. Et qu'est-ce qu'il y a ici ? Lorsqu'il y a une atteinte unilatérale, on a dit qu'il faut penser au trajet des nerfs. Est-ce qu'il y a un nerf ici ? L'anatomie, est-ce qu'il y a un nerf qui intervient dans la partie ? Oui, le 5A.

Le 5A, nerfs ophtalmiques. Donc c'est quoi le diagnostic ? Zona. Zona, quel type de zona ? Zona ophtalmique.

Ici, le trajet du nerf ophtalmique. Zona ophtalmique, très bien. Donc l'anatomie, elle sert à quelque chose.

Donc tout ce que vous avez appris la première année, la deuxième année, l'intérêt de l'IALO, c'est de les mobiliser maintenant pour résoudre les problèmes lors d'une situation clinique. La lésion alimentaire. Qu'est-ce que vous voyez ici ? C'est de la lésion alimentaire.

Les squames. Les squames, très bien. Je vous dis, il y a un nouveau nerf.

C'est de l'iozine. Ce qui est rouge, c'est de l'iozine. De l'oxygène.

Je vous dis où est-ce qu'elle est. Vous voyez ces lésions qui sont blanches, de petite taille. C'est quoi ça ? La lésion alimentaire.

Pistules, très bien. Et là, c'est une desquamation. Quel type de desquamation ? Si il y a des squames.

C'est une desquamation scarlate uniforme. C'est des morceaux de peau qui se décombre. Ici, est-ce qu'il y a une perte de substance ? Oui.

Donc on est devant une ulcération. Et l'aspect végétant. L'aspect végétant.

C'est une lésion ulcéro-végétante. Ici, c'est la topographie. L'âge, un sujet âgé.

Vous voyez ces macules pigmentés là, en rapport avec l'ensoleillement. Topographie au niveau du cœur chevelu. Donc c'est un cancer cutané.

Là, est-ce qu'il y a une perte de substance ? Oui. Il y a une perte de substance. Il y a une perte de la moitié de la lèvre.

Et qu'est-ce que vous avez ici ? Un aspect végétant. Donc on parle d'une lésion ulcéro-végétante. Donc la topographie, c'est la lèvre.

Donc ici, c'est quoi le diagnostic ? C'est un cancer. Cancer cutané. Au niveau de la lèvre, quelle est l'étiologie ? Tabac.

Tabac. C'est pour cela qu'il ne faut pas fumer. D'accord.

Donc je crois que c'est la dernière diapositive. Donc l'examen complémentaire le plus fréquent qu'on fait, c'est la biopsie cutanée. On va vous projeter un film également sur la biopsie cutanée.

Et par la suite, si vous avez des questions. Parce qu'on a des inquiétudes en espagnol. Bonjour.

Bonjour. Bonjour. Bonjour.

Bonjour. Bonjour. Bonjour.

Bonjour. Bonjour. Bonjour.

